

1. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est l'équivalent d'une crise d'angor au niveau des jambes.	1. Vrai
2. L'AOMI est une manifestation de la maladie athéro-thrombotique affectant les artères périphériques.	2. Vrai
3. L'AOMI est associée à une réduction du risque d'infarctus myocardique, d'AVC et de décès d'origine vasculaire.	3. Faux
4. L'AOMI est la conséquence d'une maladie générale athéromateuse.	4. Vrai
5. L'AOMI représente 60% des artériopathies.	5. Faux
6. Le risque d'événement coronarien ou cérébro-vasculaire est 2x plus élevé en cas d'AOMI.	6. Faux
7. Le tabagisme, l'âge, le diabète, la dyslipidémie et l'hypotension sont des facteurs de risque d'AOMI.	7. Faux
8. L'athérosclérose est responsable de la majeure partie des cas d'AOMI.	8. Vrai
9. La prévalence de l'OAMI symptomatique est relativement similaire dans les deux sexes au-delà de 65 ans.	9. Vrai
10. L'artérite diabétique est une forme moins sévère d'AOMI que l'athérosclérose.	10. Faux
11. L'AOMI est 3 fois plus fréquente chez la femme avant 65 ans.	11. Faux
12. La prévalence de l'AOMI symptomatique est de 20% après 60 ans.	12. Faux
13. Le pronostic général de l'AOMI est souvent grave car elle est associée à des lésions dans d'autres territoires.	13. Vrai

14. L'AOMI est associée à une atteinte des coronaires dans 50% des cas.	14. Vrai
15. L'AOMI est associée à des lésions des carotides et/ou des vertébrale dans 25% des cas.	15. Faux
16. L'AOMI est associée à un anévrisme de l'aorte abdominale dans 10% des cas.	16. Vrai
17. L'artérite sénile est responsable d'environ 50% des cas d'AOMI.	17. Faux
18. L'AOMI se localise le plus souvent dans l'artère fémorale profonde au niveau du genou.	18. Faux
19. L'AOMI est un processus progressif qui induit le développement d'une circulation collatérale de suppléance.	19. Vrai
20. L'artérite emboligène est liée à la migration de caillots de fibrine ou de cholestérol.	20. Vrai
21. Le stade III de l'AOMI se manifeste par des douleurs de repos.	21. Vrai
22. Les pressions de perfusion chez les patients atteints de stade IIIb de l'AOMI sont supérieures à 50 mm Hg.	22. Faux
23. Le diagnostic d'AOMI se base surtout sur l'anamnèse et l'examen clinique.	23. Vrai
24. La classification de Fontaine-Leriche permet de classer les symptômes de l'ischémie aiguë du membre inférieur.	24. Faux
25. La thromboaspiration est un traitement utilisé dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	25. Vrai
26. Les emboles dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs sont d'origine artérielle dans 80% des cas.	26. Faux
27. Les signes cliniques caractéristiques de l'ischémie aiguë des membres inférieurs suivent la règle des 5P.	27. Vrai
28. Les signes neurologiques ne sont pas pertinents dans l'évaluation de l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	28. Faux

29. L'angio-IRM est inadéquate pour les artères ayant fait l'objet d'un stenting.	29. Vrai
30. Le traitement de l'ischémie aiguë des membres inférieurs est une urgence thérapeutique.	30. Vrai
31. L'examen clinique est suffisant pour diagnostiquer l'AOMI dans plus de 80% des cas.	31. Vrai
32. L'artériographie est une technique d'imagerie non invasive pour évaluer précisément l'extension des lésions artérielles périphériques.	32. Faux
33. L'angio-IRM nécessite l'injection IV d'un produit de contraste iodé pour diagnostiquer une AOMI.	33. Faux
34. Le rétrécissement des artères dans l'AOMI entraîne une accélération progressive du débit sanguin.	34. Faux
35. La circulation collatérale de suppléance devient insuffisante au-delà d'un certain point en cas d'AOMI.	35. Vrai
36. Les douleurs de repos sont caractéristiques du stade II de l'AOMI.	36. Faux
37. La pression d'oxygène transcutanée est une technique d'exploration de la microcirculation.	37. Vrai
38. Toutes les techniques d'artériographie sont des examens invasifs.	38. Faux
39. Les pressions de perfusion augmentent en cas d'AOMI lors d'une épreuve d'hyperhémie.	39. Faux
40. Le réentraînement physique est fondamental dans le traitement de l'AOMI.	40. Vrai
41. Les antiagrégants plaquettaires ne sont pas recommandés dans le traitement de l'AOMI.	41. Faux
42. Les statines sont utilisées pour stabiliser les plaques d'athérome chez les patients atteints d'AOMI.	42. Vrai

43. Les douleurs de repos sont caractéristiques du stade III de l'AOMI.	43. Vrai
44. Les troubles trophiques dans l'artérite diabétique sont habituellement localisés aux mains et aux bras.	44. Faux
45. L'angio-CT permet une bonne visualisation des artères très calcifiées.	45. Faux
46. Les embolies passent souvent inaperçus dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	46. Faux
47. Les lésions trophiques dans l'AOMI peuvent être très minimes.	47. Vrai
48. Les pouls périphériques disparaissent dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	48. Vrai
49. Les lésions neurologiques surviennent dès la 6 ^e heure dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	49. Faux
50. Les embolies dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs sont toujours d'origine cardiaque.	50. Faux
51. L'angio-IRM est une technique d'imagerie nécessitant l'injection IV d'un produit peu néphrotoxique.	51. Vrai
52. L'examen clinique est insuffisant pour diagnostiquer l'AOMI dans la majorité des cas.	52. Faux
53. L'angio-IRM est une technique non invasive pour évaluer l'extension des lésions artérielles périphériques.	53. Vrai
54. L'angio-IRM permet une visualisation précise des artères périphériques sans utiliser de rayons X.	54. Vrai
55. Lors d'une épreuve d'hyperhémie, les pressions de perfusion diminuent et la PA augmente en cas d'AOMI.	55. Vrai
56. Le réentraînement physique est très efficace dans le traitement de la claudication intermittente.	56. Vrai
57. Les troubles trophiques dans l'artérite diabétique affectent principalement les membres inférieurs.	57. Vrai

58. Les artériographies donnent une cartographie précise de la microcirculation dans les membres inférieurs.	58. Faux
59. L'angio-CT est une d'imagerie par tomодensitométrie nécessitant l'injection IV d'un produit de contraste iodé.	59. Vrai
60. Les lésions neurologiques surviennent dans les 3 premières heures de l'ischémie aiguë des membres inférieurs.	60. Faux
61. L'angio-CT est une technique d'imagerie invasive pour évaluer l'extension des lésions artérielles périphériques.	61. Faux
62. Les pressions de perfusion augmentent lors d'une épreuve d'hyperhémie chez le sujet normal.	62. Vrai
63. Le temps de recoloration unguéale normal est inférieur à 5 secondes.	63. Faux
64. Il est recommandé de prendre les pouls périphériques à l'aide de la pulpe des doigts.	64. Faux
65. La bifurcation de l'aorte abdominale est localisée au-dessus de l'ombilic.	65. Vrai
66. Le pouls de l'artère pédieuse est pris à la face latérale du 2 ^{ème} os métatarsien.	66. Faux
67. L'insuffisance veineuse sévère peut se manifester par un œdème à godet.	67. Vrai
68. L'intensité d'un souffle vasculaire est souvent un bon indicateur du degré de sténose de l'artère.	68. Faux
69. La peau mal oxygénée est souvent rouge, fine, fragile et sans poils.	69. Faux
70. Le follicule pileux est l'une des 1 ^{ères} structures à souffrir du manque d'oxygène.	70. Vrai
71. Les patients artéritiques sont très souvent diabétiques et ont peu de sensation au niveau des extrémités.	71. Vrai
72. L'érythrocyanose déclive est caractérisée par une coloration rouge/violet du pied en position couchée.	72. Faux

73. Le test d'Allen doit être réalisée systématiquement avant une coronarographie en prévision de l'impact des lésions potentielles sur l'artère cubitale.	73. Faux
74. La pression de perfusion des membres inférieurs augmente en position debout ou assise.	74. Vrai
75. La calcifications des artères périphériques survient surtout en cas de diabète ou d'insuffisance rénale aigue.	75. Faux
76. L'artérite des membres inférieurs représente 90% des artériopathies.	76. Vrai
77. Le risque d'évènement coronarien ou cérébro-vasculaire est 6x plus élevé en cas d'AOMI.	77. Faux
78. La prévalence de l'AOMI symptomatique est de 1% avant 50 ans.	78. Vrai
79. La sévérité des symptômes d'AOMI n'est pas corrélée à l'importance de l'hypoxémie des membres inférieurs.	79. Faux
80. L'athérosclérose est responsable de 70% des AOMI.	80. Vrai
81. L'AOMI secondaire à l'athérosclérose est généralement généralisée et d'évolution relativement lente.	81. Faux
82. Les troubles trophiques sont souvent extensifs en cas d'AOMI secondaire à l'athérosclérose.	82. Vrai
83. Les artères les plus touchées par l'AOMI secondaire à l'athérosclérose sont l'aorte, les iliaques, les fémorales communes et superficielles et les poplitées.	83. Vrai
84. L'AOMI secondaire à l'athérosclérose touche principalement les sujets âgés et les hommes.	84. Vrai
85. L'artérite diabétique est présente chez 1/3 des artéritiques.	85. Faux

86. L'artérite diabétique provoquent des lésions plus distales et plus sévères.	86. Vrai
87. L'artérite diabétique est provoquée par une infiltration calcaire de la média (médiacalcoses) sans athéromatose.	87. Faux
88. L'artérite diabétique touche les sujets plus âgés, évolue plus rapidement et est multisegmentaire.	88. Faux
89. Les artères les plus touchées par l'artérite diabétique sont les artères jambières et la fémorale superficielle.	89. Faux
90. L'artère diabétique peut toucher n'importe quel gros tronc artériel.	90. Vrai
91. L'artérite sénile est liée uniquement à l'artériosclérose, c'est-à-dire le vieillissement physiologique des artères.	91. Faux
92. L'artérite sénile représente seulement 5% des AOMI.	92. Vrai
93. L'artérite emboligène est liée à la migration de caillots à partir de plaques aortiques, iliaques ou fémorales.	93. Vrai
94. Les embolies sont toujours d'origine artérielle dans l'artérite emboligène.	94. Faux
95. Les embolies peuvent passer inaperçus dans l'artérite emboligène.	95. Vrai
96. L'artérite emboligène peut se présenter sous forme de petites taches plantaires purpuriques, d'un orteil bleu ou d'un livédo.	96. Vrai
97. Les pouls périphériques ne sont plus perçus en cas d'artérite emboligène.	97. Faux
98. Le stade I de la classification de Fontaine-Leriche est caractérisé par des symptômes légers à l'effort.	98. Faux
99. La claudication intermittente est le symptôme révélateur le plus fréquent d'AOMI.	99. Vrai

100. Le stade IIa de la classification de Fontaine-Leriche est caractérisée par une claudication intermittente avec un périmètre de marche <200m de marche.	100. Faux
101. La claudication intermittente est caractérisée par l'apparition d'une douleur crampoïde après une certaine durée de marche, obligeant à l'arrêt et cédant après 1 à 2 minutes.	101. Faux
102. La localisation de la douleur d'AOMI donne une information sur la localisation des lésions artérielles.	102. Vrai
103. La claudication d'origine articulaire débute dès les premiers pas et cède rapidement à l'arrêt.	103. Faux
104. La claudication d'origine artérielle apparaît toujours après la même distance.	104. Vrai
105. Le syndrome de Leriche associe une claudication intermittente et une impuissance.	105. Vrai
106. La douleur de l'AOMI de stade III est aggravée par la station debout.	106. Faux
107. Le stade IIIc d'AOMI correspond à une ischémie critique où la viabilité du membre est menacée.	107. Faux
108. Le patient au stade III d'AOMI est réveillé la nuit par la douleur et finit par dormir au fauteuil.	108. Vrai
109. La gangrène est caractéristique de l'AOMI de classe V.	109. Faux
110. Tout traumatisme, même minime, peut entraîner une gangrène sur un terrain d'artérite.	110. Vrai
111. Le faux stade IV est un mal perforant plantaire causé par l'atteinte nerveuse et pas artérielle du diabète.	111. Vrai
112. La mesure des pressions de perfusion au Doppler permet de calculer l'indice bras-cheville.	112. Faux

113. La mesure des pressions de perfusion au Doppler complète systématiquement l'examen clinique pour le diagnostic d'AOMI.	113. Vrai
114. Le Doppler mesure les pressions de perfusion des artères pédieuses, tibiales antérieures et humérales.	114. Faux
115. L'indice bras-cheville se situe normalement entre 1 et 0,9.	115. Faux
116. Un ABI >1,4 témoigne d'artères incompressibles et suggère une médiacalcosse.	116. Vrai
117. L'indice bras-cheville est calculée à partir des pressions diastoliques les plus élevées.	117. Faux
118. L'ABI chute en-dessous de 0,9 en cas d'artérite des membres inférieurs.	118. Vrai
119. Le test de Strandness permet de déceler une AOMI qui ne devient symptomatique qu'à l'effort.	119. Vrai
120. L'épreuve d'hyperhémie inclut une mesure des pressions de perfusion avant et pendant l'effort.	120. Faux
121. La pression est plus élevée dans l'artère humérale que dans l'artère tibiale car elle est située plus proche du site de réflexion du courant sanguin.	121. Faux
122. L'épreuve d'hyperhémie est stoppée quand la douleur apparait ou après maximum 15 minutes.	122. Faux
123. Les pressions de perfusion à l'effort diminuent à l'effort au lieu d'augmenter en cas d'AOMI.	123. Vrai
124. La remontée de la pression de perfusion après un effort est d'autant plus lente que l'AOMI est légère.	124. Faux
125. Le duplex scan des membres inférieurs permet de diagnostiquer des anévrismes aortiques et poplités.	125. Vrai

126. Le duplex scan correspond à un scanner couplé à un examen Doppler en couleur et pulsé.	126. Faux
127. Le duplex scan est un examen chronophage et partiellement examinateur-dépendant mais il permet parfois de définir la thérapeutique optimale sans avoir recours à l'artériographie.	127. Vrai
128. Le duplex scan est utile pour évaluer la sévérité des lésions étendues et pour le suivi de certains pontages.	128. Faux
129. Les valeurs normales de tc pO ₂ au dos du pied chez le sujet sain debout se situent entre 40 et 60 mmHg.	129. Faux
130. La tc pO ₂ devient pathologique à partir de 35 mmHg et signale une hypoxémie tissulaire marquée.	130. Vrai
131. La mesure de la pression d'oxygène transcutanée explore la macrocirculation.	131. Faux
132. La tc pO ₂ est utile pour évaluer le retentissement tissulaire des AOMI sévères quand les PP sont d'interprétation difficiles (surélévation liée à la médiacalcose chez les diabétiques et les alcooliques).	132. Faux
133. La pression maximale d'oxygène au niveau de la peau dépend de l'âge du patient, de la PaO ₂ , du débit sanguin local et de la diffusion de l'oxygène à travers la peau.	133. Faux
134. On considère que la tc pO ₂ au dos du pied en décubitus est anormale à partir d'une valeur de 20mmHg.	134. Faux
135. L'angio-IRM est un excellent examen de première approche pour le diagnostic de l'AOMI.	135. Vrai
136. L'angio-IRM a tendance à sous-estimer la sévérité des sténoses.	136. Faux
137. L'angio-CT ne permet pas de visualiser correctement les artères très calcifiées.	137. Vrai

138.	L'insuffisance rénale et l'allergie aux produits iodés sont des contre-indications à l'angio-CT.	138. Vrai
139.	L'angio-CT nécessite l'injection d'un produit de contraste iodé dans l'artère fémorale.	139. Faux
140.	L'aorto-artériographie des membres inférieurs est un examen invasif qui nécessite un cathétérisme artériel.	140. Vrai
141.	L'aorto-artériographie des membres inférieurs ne nécessite pas l'utilisation d'un produit de contraste iodé.	141. Faux
142.	L'amélioration du confort de vie du patient n'est pas le but principal du traitement de l'AOMI.	142. Vrai
143.	Le traitement interventionnel est réservé uniquement aux AOMI de stade III et IV.	143. Faux
144.	La modification des facteurs de risque permet de diminuer la mortalité cardio-vasculaire globale.	144. Vrai
145.	Le traitement de 1 ^{ère} intention de l'AOMI devrait toujours être le réentraînement physique supervisé.	145. Vrai
146.	Le réentraînement physique permet d'augmenter significativement le périmètre de marche et d'éviter un traitement complémentaire dans de nombreux cas d'AOMI.	146. Vrai
147.	Le réentraînement doit suivre plusieurs règles pour être efficace : au moins 5x30 minutes par semaine, au moins 6 mois, à une vitesse de 3,2km/h sur un tapis incliné à 10% et jusqu'à la douleur quasi maximale.	147. Faux
148.	L'aspirine à haute dose doit être administré à tout patient souffrant d'AOMi (sauf contre-indication).	148. Faux
149.	La majorité des patients atteints d'AOMI adhère au traitement par réentraînement physique.	149. Faux
150.	Les drogues vasoactives sont très efficaces pour augmenter le périmètre de marche en cas d'AOMI.	150. Faux

151. Les prostaglandines sont réservées aux cas d'AOMI sévères chez qui il n'y a pas d'intervention possible.	151. Vrai
152. Les prostaglandines sont des molécules à la fois antiagrégantes et vasoconstrictrices puissantes.	152. Faux
153. Le traitement interventionnel invasif est proposé si le membre atteint d'AOMI est en danger (stades III et IV) et dans certains cas de claudication invalidante (stade IIb).	153. Vrai
154. La meilleure indication de traitement endovasculaires sont les sténoses localisées des fémorales communes.	154. Faux
155. Le traitement endovasculaire par ballonnet + prothèse expansive (stent) permet d'éliminer l'athérome.	155. Faux
156. Les pontages sous-inguinaux utilisent des prothèses en Dacron.	156. Faux
157. Les pontages chirurgicaux sont réalisées préférentiellement à partir d'une veine autologue en cas d'AOMI.	157. Vrai
158. Les pontages prothétiques sont beaucoup plus sensibles aux infections et ont une perméabilité à long terme nettement moins bonne que les pontages veineux.	158. Vrai
159. Les complications principales des pontages chirurgicaux sont le lymphocoele, les infections de prothèses, le faux anévrisme au site d'anastomose et l'œdème de reperfusion.	159. Vrai
160. La sympathectomie lombaire est parfois réalisée pour accroître la vasodilatation périphérique pour l'AOMI.	160. Vrai
161. La sympathectomie lombaire entraîne une peau chaude et humide au niveau des pieds.	161. Faux
162. La sympathectomie lombaire se fait toujours par voie chirurgicale.	162. Faux

163. L'ischémie aigue met en danger à court terme la viabilité et la fonction du membre atteint.	163. Vrai
164. Les lésions musculaires apparaissent après la 6 ^{ème} heure en cas d'ischémie aigue du membre inférieur.	164. Vrai
165. L'ischémie aigue du membre inférieur peut être provoquée par une phlébite bleue, c'est-à-dire une thrombose veineuse profonde étendue qui provoque un arrêt total du retour veineux.	165. Vrai
166. L'ischémie chronique du membre inférieur est caractérisée par la règle des 5P : douleur, pâleur, absence de pouls, paresthésies et paralysies.	166. Faux
167. Une dissection aortique étendue aux artères iliaques peut provoquer une ischémie aigue du membre inf.	167. Vrai
168. Une thrombose peut être liée à un haut débit systémique dans le cadre d'une toxi-infection.	168. Faux
169. L'embolie est majoritairement d'origine cardiaque en cas d'ischémie aigue des membres inférieurs.	169. Vrai
170. Des troubles sensitifs surviennent à cause de l'ischémie des vasa vasorum en cas d'ischémie aigue du MI.	170. Faux
171. Les signes neurologiques (mobilité et sensibilité) témoignent de la gravité d'une ischémie aigue.	171. Vrai
172. Le traitement de l'ischémie aigue du membre inférieur est une urgence car des lésions irréversibles surviennent au-delà de 8 heures d'ischémie.	172. Faux
173. La sonde de Fogarty permet l'exérèse chirurgicale des embolies en cas d'ischémie aigue du MI.	173. Vrai
174. L'ischémie aigue du MI peut être traitée par reperfusion pharmacologique à l'aide d'anticoagulants.	174. Vrai